

QCM Pédiatrie

Référence : Lissauer T, Carroll W. Illustrated textbook of paediatrics. 5th ed.

Enoncé 1 : 6 semaines, BSH, vomissement depuis 5 jours en jet. Affamé, tête vigoureusement, afébrile, pas de diarrhée, poids stable depuis 5j.

EC : PV normal, légèrement hypotendu

Q1 : Diagn :

- Sténose hypertrophique du pylore.

Volvulus sur malrotation possible sur tous petits bébés, vomissement plutôt biliaire (que alimentaire).

Atrésie duodénale : liée au sy de Down, plus rare, problème arrive quasi dès la naissance.

Q2 : examens complémentaires :

- Dosage de la glycémie
- Gazométrie/gaz sanguins : alcalose métabolique
- Dosage électrolytes : utile car svt en déficit sur les vomissements

PEC : réhydratation avt la prise en charge chir qui n'est pas urgente

Q3 : quel examen pour confirmer la sténose ?

- US abdo

2^e énoncé : 5 semaines, cyanose des lèvres lors des pleurs. Grossesse et accouchement sp.

EC : afébrile, 110 bpm, 85/55, cyanose généralisée lors des pleurs

Souffle systolique grade 3-4/6 au foyer pulmonaire...

Q1 : diagn :

- Tétralogie de Fallot (sténose sous-valvulaire pulmonaire, CIV très large donc ne fait pas de souffle)

Communication interventriculaire : n'est pas cyanogène

Transposition des grands vx : cyanogène, svt malformations associées

Coarctation de l'aorte et sténose mitrale sont non cyanogènes

Q2 : examen complémentaire ?

- ECG
- ETT
- Rx du thorax : pour voir forme et taille du cœur, perfusion pulmonaire

Q3 : médicaments lors d'un épisode de cyanose soudaine (crise hypercyanotique) ?

- Oxygène
- Bbloquant
- Morphine : on sait pas comment mais aide aussi le passage du sang à travers la sténose pulm
- Bolus de 20ml/kg de NaCl 0.9%
- + replier les jambes du bébé sur lui

On essaye d'augmenter la R périphérique pour que + de sang arrive mieux à passer à travers la sténose sous-pulmonaire.

3^e énoncé : 10 ans, drépanocytose, tt d'hydroxyurée, EF 38.5, douleurs osseuses bras G et jambe. D. TT antalgique paracétamol et AINS.

Q1 : PEC ?

- Prélever une hémoculture et commencer traitement de ceftriaxone
- Proposer tt de fentanyl intra-nasal (elle a déjà eu antalgie de 1^{er} pilier à la maison donc on peut monter car c'est très douloureux)

Drépanocytose —> comme un déficit immunitaire, donc tt ATB rapide pour éviter sepsis.

Q2 : revient 4 semaines + tard, EF 38.2, fatigue, éruption cutanée maculo-papulaire sur le tronc, membres et joues. Sous traitement d'acide nalidixique depuis 5 jours pour infection urinaire à E.Coli sensible. Hb habituelle autour de 85g/L, maintenant 65g/L. Pourquoi péjoration de l'anémie ?

- Crise aplastique sur infection à parvovirus (infecte préférentiellement les précurseurs de GR, les réticulocytes ?)

Crise hémolytique sur acide nalidixique : c'est les patients qui ont un déficit en G6.... ?

Crise sur séquestration splénique : surtout petit enfant 1-2 ans avec drépano, font une splénomégalie très importante.

Enoncé 4 : 10 ans, difficultés scolaires depuis 8 mois. Il se lève sans cesse de sa chaise, dépasse tout le monde, court sans cesse, interrompt les conversations... Examen physique y compris neuro sp.

Q1 : diagn ?

- Déficit d'attention avec hyperactivité

Q2 . PEC ?

- Psychothérapie comportementale
- Méthylphénidate

Enoncé 5 : bébé 20 jours, fébrile à 38.4, pas de toux, ni de diarrhée, vomi 1x, pleure, mange moins bien. EC : légèrement marbré en périph, TRC < 3s, reste sp.

Q1 : PEC ?

- Hémoch, analyse et culture de LCR, examens d'urine.

Cut-off pour ne pas faire la PL : 21 jours

Q2 : Pro-calcitonine 0.4, CRP 10, pas de leucocyturie, LCR 1 leuco, hémoch et culture LCR en cours. Traitement ?

- Amoxiciline (couvre Listeria) et gentamicine (Gram - ?) : pour couvrir les germes Strepto B, E. Coli et Listeria (les + courant/dangereux chez petit bébé).

Ceftriaxone et cipro est contre-indiquée chez bébés < 3 semaines (risque de toxicité, en lien avec la bilirubine).

Énoncé 6 : Mort subite, conseils pour prévenir ?

- Faire dormir le bébé sur le dos (conseil encore + efficace que stop tabac)

Lolette c'est plutôt protecteur aussi.

Énoncé 7 : 10 mois, EF progressif, toux rauque, stridor inspi, détresse resp discrète = faux-croup/Laryngite¹ (rétrécissement sous les cordes vocales). Pathogène impliqué ?

- Virus para-influenza

RSV cause plutôt bronchiolite.

H. influenzae : provoquait épiglottite avant vaccination

Diphthérie : peut aussi faire obstruction resp avec membranes grisâtres (mtn on est vacciné)

Q2 : augmentation de la FR, tirage, stridor audible au repos, diminution de l'entrée d'air à l'auscultation. PEC ?

- Aérosol d'adrénaline : pour faux-croup moyen à sévère, vasoconstriction facilite passage de l'air.

Corticoïde topique n'aide pas en aiguë car met env 1 semaine à agir mais dexaméthasone = tt de base pour le faux-croup.

Enoncé 8 : NN de 3500g, né à 39 semaines, grossesse sp, Apgar 8-9. T 37, 120 bpm, TA 55/35.

Clitoromégalie. Examens complémentaires : sp. US des ovaires et utérus sp. --> Hyperplasie congénitale des surrénales. PEC :

- Traitement d'hydrocortisone et fludrocortisone (en urgence, à vie ou en tout cas jusqu'à l'âge adulte)

Enoncé 9 : 8 ans, épisodes où il paraît rêver pendant la journée, difficultés scolaires depuis plrs semaines, EEG montre des décharges bilat de pointes-ondes à une fréquence de 3Hz (particulier à l'épilepsie absence) qui commencent et s'arrêtent de manière abrupte. Diagn de présomption ?

- Épilepsie absence = épilepsie généralisée

DD : crise d'épilepsie partielle avec trouble de la conscience mais il n'y aurait pas un EEG bilat.

Enoncé 10 : 16 mois, irritable, veut pas manger, 39.4, légères dlrs abdo. PEC la + adaptée ?

- Stix +/- culture urinaire après sondage urinaire

EF sans foyer, étiologie la + freq = infection urinaire.

CUM (cysto-uréthrographie), indications + restrictives mtn : dilatation à l'US ou PN récidivante

Enoncé 11 : naissance 37 SA, après 72h de rupture des membrane, Apgar à 4 à 5 min. Détresse respi.

Hémoculture = cocci Gram + en chainettes. Germe le + probable ?

- Strepto du groupe B : le + souvent trouvé chez les NN

Enoncé 12 : photo, 6 ans, multiples lésions sur sa face et ses avant-bras, T 37.9 = impétigo (germes = S. aureus et Strepto du groupe A). TT ?

- Flucloxaciline

Amoxiciline et péniciline marche pas contre strepto.

Enoncé 13 : 11 mois, fracture du fémur D sur chute en passant au-dessus des barreaux de son lit, hématomes sur les épaules et le dos. Ortho proposent tt conservateur avec plâtre. Suite de la PEC ?

- Fond d'œil

¹ Laryngo-trachéo-bronchite

Tableau doit faire penser à une maltraitance, donc enfant ne rentre pas à la maison pour qu'on le protège. Souvent s'il est secoué on peut retrouver des hémorragies du fond de l'œil (surtout chez petits < 1 an)

Pour continuer, on peut faire des Rx de tout le corps entier pour voir s'il y a d'autres fractures.
CT-scan cérébral si signes neuro.

Enoncé 14 : 7 ans, dev de tissu mammaire, pilosité débutante sur le pubis, taille et poids au percentile 80. PEC ?

- RX du poignet

Puberté précoce = < 8 ans. Age osseux avancé de + de 2 ans. On va aussi faire dosage hormonal complet, US...

Enoncé 15 : 14 ans, douleurs et tuméfaction de genou G depuis 43 jours, jouait régulièrement au football, a du arrêter. Pas de trauma. Œdème avec douleur en regard de la TTA. Rx montre fragmentation de la TTA. Diagn :

- Maladie d'Osgood-Schlatter (apophysite, qui correspond au pic de croissance associé à l'endroit impliqué, le + souvent la tubérosité tibial antérieure)

Sarcome d'Ewing : lésions d'ostéolyse de la diaphyse des os long.

Legg-Calvé Perthes : ostéochondrite de la hanche vers 8 ans.

Enoncé 16 : 4 ans, BSH, douleurs dans les 2 jambes depuis 3 semaines. T = 37.8, pâleur des lèvres et des conjonctives. Pétéchies sur la peau, rate à 3cm du rebord costal. Pas de limitation de la mobilité des articulations, ni de tuméfaction. FSC : GB 1.6 G/l et Hb 69 et plaquettes 36 G/l. Diagn :

- Leucémie aiguë lymphocytaire : y penser dès qu'il y a une bicytopénie

Arthrite juvénile idiopathique : rhumatisme infla, plusieurs formes :

- 4-5 ans : oligo-articulaires qui touchent plutôt les genoux, plutôt filles, articulations rouges et douloureuses
- Autre forme ?

Enoncé 17 : NN de 3j, plis fessiers asymétriques, né par CS pour non progression de l'accouchement, afébrile, 125 bpm, FR 50/min, 3.2kg, Hanche G est facilement luxable postérieurement avec ressaut et clic. Craquement quand retourne dans position normale. Examen diagnostique ?

- US des hanches

US de détection, indication : accouchement en siège, anamnèse familiale de dysplasie de hanche, oligoamnios, grossesse gémellaire.

Enoncé 18 : NN à terme, naissance par siège, examen neuro : réflexe de Moro asymétrique avec bras G qui ne bouge pas. Quand on soulève bras G il retombe. En position de repos, il reste en adduction, rot interne avec avant-bras en pronation. Réflexe de grasping normal ddc. Diagnostique ?

- Paralysie d'Erb (plexus brachial C5-6) : se remet bien avec physiothérapie

Fracture de la clavicule : douleurs à la palpation et pas la même position du bras.

Leucomalacie péri-ventriculaire : diplégie spastique

Hématome sous-dural : paralysie d'un hémicorps

Lésion de la ME : atteinte symétrique

Enoncé 19 : 12 ans, palpitations commencent et s'arrêtent soudainement, durent quelques heures, anamnèse familiale sp. ECG : onde delta. Diagn ?

- WPW

Enoncé 20 : 12 ans, pertes vaginales depuis 2 mois, jamais eu de relations sexuelles. Seins qui se dev depuis 2 ans, examen du périnée montre pilosité de stade Tanner III sans rougeur du périnée ni irritation vulvo-vaginale. Petite quantité de mucus sans odeur est observé.

- Pas de traitement

Enoncé 21 : 10 ans, AVP, multiples blessures à la tête, bras, abdomen, TA 90/60, FC 120 bpm. Avant-bras déformé avec fragment d'os qui ressort. Abdomen rigide et douloureux. PEC :

- Administrer une solution cristalloïde

Enoncé 22 : 3 semaines, EF 38.9, né à terme par AVB, culture urine, sang, LCR = trouble —> Méningite bactérienne. Complication la + fréquent que peut présenter cet enfant ?

- Déficit auditif

Abcès cérébral : conditions particulières (cardiopathie avec choc), bactérie qui passe directement dans la circulation systémique.

Kernicterus : toxique dans les noyaux de la base ?

Enoncé 23 : 10 mois, vomissements biliaires depuis 6h, dlrs abdo intermittentes, pleurs intenses, selles gelée de groseille dans la couche. Masse dans le quadrant inf D de l'abdomen. Diagn ?

- Invagination iléo-colique

PEC : US, réduction par lavement.

Volvulus intestinal : vomissements biliaires

Entérocolite nécrosante : plutôt les prématurés

Enoncé 24 : 4 mois avec constipation chronique, abdomen distendu, pas de sang ou selles dans l'ampoule rectale. Méconium au 4^e jours. Diagn :

- Hirschsprung (mégacolon congénital) : retard d'émission du méconium, ampoule rectale vide (vs constipation fonctionnelle)

Botulisme : peut aussi causer constipation chez bébé, mais atteint souvent les NC aussi

Enoncé 25 : 3 ans, énurésie nocturne, propre de jour depuis 6 mois, continue à mouiller son lit la nuit. Pas de sy urinaires comme dysurie ou urgences mictionnelles. PEC :

- Réassurer les parents et leur expliquer qu'il s'agit d'une situation normale dans l'acquisition de la propreté et du contrôle sphinctérien.

Trop jeune pour qu'on mette en place pipi-stop, ou poser des questions sur le stress familial (plutôt vers 8-9 ans). Propre de jour et pas de nuit c'est physiologique à 3 ans

Partie 2 :

Q1 : Examen du NN, poids de naissance en dessous du 5^e percentile, petites fentes palpébrales, microcéphalie et philtrum plat. Parmi ces substances, laquelle la mère a été le plus probablement en contact durant sa grossesse ?

R : Alcool

Plomb : se trouve dans les tuyaux

Mercure : + rare, très peu étudié

Benzène : cancer de la vessie

Monoxyde de carbone : hb fœtale à une meilleure affinité pour le CO, donc enfant meurt en premier.

Q2 : 16 ans, toux principalement nocturne, sans sécrétions de mucus, dyspnée depuis 3 semaines. Nie la présence de fièvre ou de douleurs. Symptômes semblables de moindre intensité il y a un an, également au printemps. Pour confirmer la suspicion diagnostique, quel examen est le plus approprié ?

R : spirométrie

TT... pas eu le temps de noter : CSI + LABA (symbicort) ?

Q3 : 15 ans, éruption par plaques rouges et desquamantes sur le nez et les joues. Aussi lésions érythémateuses et desquamantes sur la face dorsale des doigts. Anémie et protéinurie.

Diagnostic ?

R : LED (atteinte rénale dans env 50-60% des cas)

Autres propositions : dermatomyosite (lésions violettes autour des yeux, associé à une faiblesse des muscles), arthrite juvénile idiopathique, eczéma atopique, réaction médicamenteuse.

Q4 : 6 ans, EF à 39 degrés, maux de gorge, douleurs articulaires depuis 2 jours. Pas de toux, pas de rhume. 2h avant son arrivée aux urgences, il présente des céphalées et dlr abdo avec 1x/vomissement. EC : hypertrophie bilat des amygdales avec exsudat et lymphadénopathie cervicale antérieure bilatérale. Examens complémentaires indiqués :

R : pas d'examen —> changement d'attitude en 2022 :

Frottis si critères d'inquiétude + score de Centor > 3

- Signe d'alerte clinique (mauvais état général², suspicion d'abcès péri-amygdalien/rétropharyngé)
- Risque augmenté de complication

Référence : angine à streptocoque chez l'enfant : traiter ou ne pas traiter ? Paediatrica 2023.

Donc ici on fait un tt symptomatique avec contrôle à 48-72h.

Autres propositions : frottis de gorge pour le strepto du groupe A, frottis H. Influenzae (moins probable car on est vacciné, et présentation clinique plutôt sous forme d'épiglottite), Rx latérale du cou (pour les abcès), vitesse de sédimentation.

Douleurs articulaires = arthrite péri-infectieuse (bénin, auto-résolutif)

Q5 : Examen médical de l'école, fille de 16 ans sans plaintes, tension artérielle de 85/50. Reste de l'examen normal. Recommander :

R : ne pas s'en préoccuper

² PV altérés (tachycardie, hypotension, TRC > 3s), si un des organes est mal perfusé (état de conscience modifié, oligurie)

Critères d'investigation d'une hypotension : si symptômes (ex : syncope, lipothymie, céphalées, trouble de l'équilibre... pas le cas ici). Beaucoup de gens ont des tensions + basses physiologiques.

Q6 : 15 ans, salle d'accouchement à 36 semaines, perdu les eaux il y a 4 jours. Rares contractions utérines, col perméable à un doigt, pas de fièvre. Provocation par ocytocine, 10h plus tard, met au monde fille de 3kg, Apgar 6 puis 9. FR le + important pour une infection nn :

R : Rupture prématurée de la poche des eaux

FR : EF lors de l'accouchement, présence de strepto B et absence des ATB sensés le traiter, herpès (si présence de vésicules c'est contagieux, si maman sympto, elle transmet ses Ac qui protègent bébé, ce qui est dangereux c'est la primo-infection). Donc l'anamnèse négative d'herpès génital chez la mère n'exclut pas une encéphalite à herpès chez petit bébé (2 semaines).

Q7 : camps de réfugié, enfant de 2 ans, 3 jours de fièvre à 40 degrés, toux, rhinite, conjonctivite. Photophobie, conjonctivite, rash maculaire derrière les oreilles, sur le visage et le tronc. Tout est vrai sauf ? C'est la rougeole

R : On la traite par ATB (c'est faux)

Rougeole : maladie mortelle, très contagieuse, pour laquelle on dispose d'un vaccin, complications à long terme (panendo... sclérosante ?).

Q8 : Quelques jours après résolution d'une infection virale, garçon de 7 ans se présente en raison d'une marche titubante, ataxie, anomalie des épreuves doigt-nez et talon-genou. Virus le plus probablement en cause ?

R : VZV. Fréquent d'avoir une encéphalite ou cérébellite post infectieuse

HSV : plutôt local, peut faire une encéphalite mais souvent assez diffus

CMV : rarement sympto (sauf si tout petit), possible encéphalite mais rare

EBV : possible de faire encéphalite mais moins fréquent

Hépatite A : encore plus rare voir pas du tout (prof est pas sur)

Q9 : 4 ans, reflux vésico-urétéral modéré présente des infections urinaires à répétition malgré ATB prophylaxie. Prise en charge la plus appropriée ?

R : Chirurgie anti-reflux

Grade de reflux : I à V,

- Minime = grade I et II
- Moyen = grade III (peu de résolution chez > 5 ans)
- Grave = grades IV et V

Q10 : bébé de 10 jours, né 15 jours avant terme, poids 2500g, émis méconium à 12h, et s'est alimenté normalement. Vomissements teintés de bile, apathique, refuse de téter, T à 36, pas été à selles depuis 12h. Abdomen souple, douloureux. Diagnostique de présomption ?

R : volvulus intestinal (fréquemment sur malrotation)

Hirschsprung : non c'est pas ça haha

Atrésie intestinale : non car il a mangé normalement au début

Sténose du pylore : vomissement plutôt alimentaire, bébé en bon état général

Invagination : selles en gelée de groseille, douleurs on/off

Q11 : 13 ans, obèse, dlrs à la hanche depuis 2 mois. Diminution de la rotation interne de la hanche G. Cause la plus vraisemblable ?

R : Epiphysiolyse de la tête fémorale

Q12 : 5 ans, ET 39.6, contexte de baisse de l'état général, irritabilité et vomissement. 3 derniers jours : a reçu haute dose d'amoxiciline en raison d'une otite bilat. Apparence toxique.

Examen du LCR : glucose diminué à 0.56, protéines élevées à 1.5g/l, 620 GB, prédominance de PMN, pas de globules rouges. Coloration Gram : pas de germes décelables. Diagnostic le plus probable :

R : méningite bactérienne décapitée

On s'attend à avoir des GB plus élevés dans une méningite bactérienne, ici c'est en raison de l'amoxiciline.

Méningite à Lyme : se présente pas pareil

Q13 : 12 ans, maux de gorge violent, dysphagie d'abord aux solides puis odynodysphagie aux liquides, vaccins à jour, EF 38.9, amygdale G est enflée, voile du palais bombant, luette déplacée. L'amygdale D normale. Diagnostic :

R : Abscess amygdalien

Gingivostomatite herpétique : lésion de toute la bouche, principalement gencives et palais.

NB : Si n'arrive plus à avaler sa salive —> 144, car on est à 2 doigts de l'obstruction totale

Diphthérie : toux rauque, pseudo-membrane, EF élevé

PEC ici : ATB IV et cortico, CT, drainer si on peut (geste ORL)

Q14 : 8 ans, éruption prurigineuse aiguë sur les bras et les jambes (papules, taches et vésicules alignées de façon linéaire). Déjà présenté par le passé le même type d'éruption après avoir touché une plante. Diagnostic ?

R : Dermite de contact

Impetigo : croûtes mélicériques, début de cellulite associé

Q15 : 4 ans, refuse de marcher depuis qu'il s'est levé ce matin. La semaine passée il a présenté une IVRS. Actuellement, T 37.2, status dans la norme à part limitation douloureuse de l'abduction et de la rotation externe de la hanche D.

Formule sanguine : leuco 11.2 G avec 6% de neutrophiles non segmenté, CRP à 25 mg/l

US montre un épanchement intra-articulaire de faible importance. Diagnostic :

R : synovite transitoire de la hanche (rhume de hanche)

Arthrite septique : fièvre, US qui montre du pus, CRP plus élevé (mais si on est tot, ça peut ressembler)

Maladie de Perthes = nécrose aseptique de la tête fémorale

Q16 : 3 ans, fièvre quotidiennement depuis 7 jours, surtout la nuit, lèvres sèches et érythémateuses, langue framboisée, conjonctivite bilatérale, érythème multiforme, ADP cervicales et splénomégalie.

Examen sanguin : anémie, leucocytose. Strepto test neg, facteur rhumatoïde neg, sérologies de Lyme neg. Rx du thorax neg. Diagnostic :

R : Kawasaki, critères diagnostiques

- Fièvre durant > 5 jours
- 4 des 5 critères suivant :
 - o Injection conjonctivale bilatérale non exsudative
 - o Anomalies au niveau des lèvres, de la langue ou de la muqueuse buccale (injection, sécheresse, fissuration, langue rouge framboise)
 - o Anomalies des extrémités (œdème, érythème, desquamation)
 - o Exanthème polymorphe du tronc
 - o ADP cervicales (au moins 1 gg de > 1.5cm)

Kawasaki = vasculite des gros vx, touche les coronaires donc complications = anévrysme des coronaires —> IC des enfants.

TT : aspirine (dose anti-inflammatoire puis anti-aggrégante pour diminuer le risque des complications liés aux anévrysme) + Immunoglobuline (pour diluer les auto-ac)

Scarlatine : pharyngite avec strepto groupe A, rash en papier de verre, pas sensé faire une splénomégalie.

Q17 : 6 mois, EF à 40, très irritable, fontanelle tendue. PL au 3e jour est normal. Au 4e jour, apparait sur le tronc un exanthème formé de petites taches rouge clair, l'enfant devenant en même temps afébrile. Diagnostic ?

R : roséole (exanthème subit, HSV6) : 3 jours de fièvre super haute puis résolution d'un coup

Une infection virale à Coxsackie ?

Q18 : A la maternité, évaluation d'un NN à terme de 6h de vie qui a développé une tachypnée à 100/min, grunting, rétraction sus-sternale, pas de cyanose. Auscultation pulmonaire est propre sans ronchis ni râles. Rx du thorax montre une accentuation de la trame broncho-vasculaire. Silhouette cardiaque normale. Diagnostic :

R : Tachypnée transitoire du NN : apparait 6-12h après la naissance, nécessite un peu d'aide inspiratoire et d'oxygène.

Maladie des membranes hyalines : ancien prenat trop exposé à l'oxygène + déficit en surfactant (conséquence de stress oxydatif, mécanique...)

Aspiration méconiale : c'est pas ça (lol pourquoi)

Pneumonie virale : non car auscultation et Rx sp et pas de FR d'infection NN à priori

Insuffisance cardiaque : exclu car Rx normal

Q19 : 8 mois, tétralogie de Fallot. Sa mère remarque soudain qu'il devient tout gris alors qu'elle est en salle d'attention de consultation de cardio. Jason est positionné en position genou-pectorale mais cela ne change rien. Traitement approprié ?

R : bêta-bloquant intra-veineux

Prostaglandines maintient le canal artériel ouvert, typiquement utilisé pour tt la transposition des gros vx. A utiliser dans les heures qui suivent la naissance.

Traitement de la crise de la tétralogie de Fallot (nom ?) :

- Morphine
- O2
- Position genou-pectoral

- Bbloquant : pour relâcher le spasme de l'infundibulum ?, augmente le shunt D-G

Q20 : 18 mois, bon état général, depuis quelques semaine écoulement jaune verdâtre, d'odeur fétide, provenant de la narine D. Diagnostic le + probable ?

R : un corps étranger dans la narine D

Sinusite maxillaire ou ethmoïdal : pas impossible mais moins probable, touche souvent les 2 narines (en particulier chez l'enfant)

On naît avec sinus maxillaire et ethmoïdaux, les autres arrivent + tard (frontal vers 2 ans, sphénoïdal vers 3 ans)

Q21 : Nourrisson de 3 semaines qui présente des selles défectueuses fréquentes, mêlées à du sang, prise pondérale faible, une colite est suspectée (l'enfant est exclusivement allaité). Que faites-vous pour déterminer une éventuelle allergie alimentaire à l'origine de cette colite ?

R : régime sans protéine bovine chez la mère

On pense à l'APLV qui est le + fréquent (autres allergies fréquentes : cacahuète, poisson, kiwi, œufs, pollen, graminées, fruits à coques, crevettes et fruit de mer, crustacés...)

Si on mesure IgE il faut faire la totale, mais APLV c'est pas IgE médié. Prick test marche pas non plus.

Q22 : NN de 2 jours, détresse respiratoire depuis la naissance s'aggravant progressivement, il a aussi des vomissements à chaque tentative d'alimentation, n'a pas émis de méconium. AF et grossesse sp. Poids de naissance 3800g, FC à 152/min, FR à 68/min, tirage intercostal.

L'auscultation des plages pulmonaires révèle un murmure vésiculaire diminué au niveau de l'hémithorax G, abdomen légèrement excavé, palpation ne pas en évidence d'HSM, l'auscultation abdominale montre de rares bruits de tonalité normal.

Rx du thorax : anse dig dans l'hémithorax G, déplacement du médiastin vers la D. Diagnostic ?

R : Hernie diaphragmatique

Fistule trachéo-oesophagien : à chaque fois qu'on le nourrit, il désature (va pas forcément vomir).

Q23 : 6 ans, rash prurigineux depuis 2 semaines, augmente et s'aggrave la nuit, pas d'atcd de maladies cutanées. Nombreuses papules érythémateuses de 2mm de diamètre localisées entre les doigts dans les plis cutanés, sous les aisselles, à la ceinture, sur le gland et le scrotum. Diagnostic : la Galle. TT :

R : Permethrine

Q24 : NN, ictère, pas de détresse resp, bon cri, auscultation Cardio-pulm sp, reste de l'examen sp, mère pas trop eu de suivi de grossesse, mais en tout cas sérologies syphilis (neg) et rubéole (immun), pas eu de test d'incompatibilité de groupe sanguin. Mère a consommé des drogues par le passé. Diagnostic :

R : hépatite B

Première cause d'ictère chez bébé = sepsis NN

PEC : Ac et vaccin ??

Q25 : 14 ans, fièvre, amygdalite caractérisée par la présence de membranes gris-blanchâtres qu'on peut facilement détacher, ADP généralisée, exanthème maculo-papulaire, augmentation des lymphocytes et monocytes. Diagnostic :

R : EBV.

Q26 : 13 ans, mauvaise posture, asymétrie des épaules et des hanches, gibbosité quand elle se penche en avant.

- Idiopathique dans la maj des cas : vrai
- Plus fréquente à l'adolescence : vrai
- Elle est typiquement accompagnée de douleurs et d'une raideur : faux
- Peut être associée à la neurofibromatose, sy de Marfan et à la mucopolysaccharidose : ?

Q27 : contrôle des 6 ans, souffle systolique à l'auscultation cardiaque. Lesquelles de ces propositions nécessitent une investigation plus poussée :

- Thrill à la palpation : oui
- Disparition du souffle en position assise : faux
- Souffle diastolique doux associé : vrai
- Dyspnée à l'exercice : vrai

Q28 : 18 mois, crise et pleurs, en a perdu le souffle et son visage est devenu tout bleu, a duré env 1-2 min. Ce matin dans les mêmes circonstances, après s'être mis dans une grande colère, épisode identique, mais a perdu connaissance pendant un temps que la maman n'arrive pas à préciser probablement quelques minutes, sa figure était à nouveau toute bleue.

Diagnostic : spasme du sanglot. Attitude ?

R : Pas de tt à instaurer, c'est bénin et ça disparaît tout seul dans 80% des cas.

Spasme du sanglot :

- Cyanotique
- Acyanotique : on devient blanc et on tombe dans les pommes

Q29 : 2 semaines, vomissement et diarrhées, mauvais appétit. Examens complémentaires : Hyponatrémie, hyperkaliémie, le reste est normal. Diagnostic ?

R : Hyperplasie congénitale des surrénales (blocage de la 1-25-hydroxylase ? + hypersexualisation des OGE féminins)

Q30 : 4 ans, BSH, non vacciné, EF ++ d'apparition soudaine, accompagné d'un stridor inspiratoire et d'un refus de boire. Suspicion d'épiglottite. Garder l'enfant en position assise.

Q31 : 14 ans, dlrs dans le bas abdomen... Torsion testiculaire vs de Morgagni (tache bleue sur la partie sup du testicule)

Q32 : 21 mois, dénutri, tête disproportionnée, épaississement de ses chevilles et poignets, protubérances aux jonction costo-chondrales, Rx : montre épaississement des plateaux épiphysaires. Diagnostic : Déficit en vit D (pour ça qu'on donne une prophylaxie jusqu'à 3ans).